

Brain & Mind

Hot Issue

재택의료의 경험과 앞으로의 방향
이상범 / 서울신내의원

재택의료의 경험과 앞으로의 방향

이미 유례없는 초고령화 사회가 된 일본은 지금 우리가 고민하고 있는 문제들을 먼저 고민했습니다. 재생산 가능 인구나 노동력이 감소해 의료진, 의료기관의 병상 수와 요양시설 수가 절대적으로 부족하여 앞으로 연간 3만 명이 고립사할 것이라는 보고가 나왔습니다. 게다가 기존의 시스템으로는 천문학적으로 치솟는 의료비와 사회보장비를 감당할 수 없을 것이라는 위기감에 일본은 사회 시스템의 변혁을 서둘렀습니다.

그리하여 일본 정부는 2025년까지 병상 20만 개를 감축할 계획을 세우고, 의료와 돌봄을 의료기관에서 지역사회로 옮기고 있습니다. 입원 진료에 따른 의료비 지출은 억제하고, 지역사회 차원에서 의료와 복지 수요에 대응하고 있습니다. 이러한 시스템의 변화를 완성하기 위해 환자가 집에서 의료 서비스를 받을 수 있는 재택医료를 전면 도입했습니다.

후생노동성 의료시설조사에 따르면, 지난 2020년 기준 일본 병원의 65.3%, 진료소(의원급 의료기관)의 34.3%가 의료보험에서 보장하는 재택의료 서비스를 제공하고 있다고 합니다. 재택의료 이용자 또한, 일본에서 재택의료로 도입된 2006년 19만여 명에서, 2025년 100만 명을 돌파할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 재택의료 이용자의 90% 이상이 75세 이상 후기 고령자

입니다.

그러면 현재 대한민국은 어떨까요? 조금 먼저 재택医료를 경험하고 있는 제 경험에 비추어서 설명드리겠습니다.

저는 2011년 개업하여 신경계질환에 폐렴, 욕창, 요로감염 등 중증의 합병증이 동반된 환자들을 입원 치료하는 〈서울신내의원〉을 운영하고 있습니다. 아무래도 평일 주간에는 외래 진료가가 거의 없는 상태였기 때문에, 이 시간을 어떻게 활용하면 좋을까 고민이 많았습니다.

그러던 중에 거동이 힘들어 병원을 갈 수 없는 환자들을 시설과 병원이 아닌 집에서 의료와 돌봄 서비스를 받게 한다는 ‘커뮤니티 케어’ 아젠다가 논의되었고, 2019년에는 〈일차 의료 방문진료 수가 시범사업〉(이하, ‘일방시’)이 시작되었습니다. 중증 신경계질환 환자들은 상급병원 신경과에서 보호자가 대리 처방으로 약만 챙겨가는 경우가 많았으므로, 저는 방문진료를 통해 이분들을 진료할 수 있다면, 의사와 환자 모두에게 좋은 의료 서비스가 될 수 있으리라 생각했습니다.

그렇지만 2019년의 방문진료는 의사와 환자 모두에게 어색한 진료 형태였습니다.

제가 방문진료를 가겠다고 해도 환자와 가족들 입장에서는 굳이 의사가 집에 오는 것에 대한 부담을 가졌었고, 정말 급한 경우에만 영양 수액, 욕창 치료, 도뇨관 교체,

소견서 발급 등의 일회성 진료가가 대다수였습니다. 저는 정기적인 방문진료를 통해 규칙적인 재택의료 서비스를 받을 것을 권유했지만, 기존에 진료해 주신 병원의 교수님을 더 신뢰하는 환자와 보호자가 대부분이었습니다. 이미 담당 교수님은 환자가 병원에 오지 못해 직접 진료할 수도 없고, 거의 비슷한 약만 루틴으로 보호자 대리 처방하고 있는 상황인 데도 말입니다.

그런데 코로나19 팬데믹이 방문진료를 변화시켰습니다. 요양병원과 시설에서의 집단 감염, 면회를 할 수 없는 현실, 뉴스 등에서 보도되는 학대 사건들로 거동이 불편한 환자들을 입원 치료받는 것을 꺼려하게 되었습니다. 그리고 이렇게 집에서 지내는 환자분들의 신청이 늘어나면서 저도 방문진료 건수가 이전보다 빠르게 늘어나게 되었습니다.

그리고 2022년에는 〈일방시〉에 참여하고 있는 의료기관 중 실적이 많은 의료기관을 선정하여, 추가로 인센티브가 주어지는 〈장기요양 재택의료센터 시범사업〉(이하, ‘장재시’)에도 참여할 수 있었습니다. 〈일방시〉와 〈장재시〉의 사업 구조와 수가는 〈표 1〉과 같습니다.

〈일방시〉와 〈장재시〉 외에도, 〈장애인권장주치의 시범사업〉, 〈치매관리주치의 시범사업〉 등의 다른 시범사업을 통해서도 방문진료는 가능하지만, 제가 활발하게 참

표 1.

	일차 의료 방문 진료 수가 시범사업	장기요양 재택의료센터 시범사업
참여 기관	모든 의원급 의료기관 참여 가능. 1년에 2회 신청 기간이 공고됨.	〈일방시〉에 참여 중인 의원급 의료기관 중 방문 진료 실적 이 높은 의료기관과 해당 지자체에서 추천된 의료기관 중 에서 보건복지부가 선정. 간호사, 사회복지사 고용해야 함. 현재 전국에 90여개 재택의료센터가 선정됨.
수가	의사 혼자 방문 진료 시, 방문 진료료 1, 128,960원(IA001). 간호사/물리 치료사/작업 치료사는 동반 인력이 가산되어 161,790원(IA001010). 위 수가는 포괄 진료 수가이며, 행위별 청구하려면 방문 진료료 2, 89,720원(IA002). 동일 세대, 동일 건물 방문 진료 시 감산. 의료 접근성 취약지기관 방문 시 가산 월 60건 제한.	의사가 월 1회, 간호사가 월 2회 이상 방문 진료 시 월 14만 원 인센티브. 방문 진료 수가와 동시 청구. 월 100건 제한.

여하지 않는 시범사업이라, 본 글에서는 언급하지 않겠습니다.

정리하자면, 병원을 갈 수 없어 의료 서비스를 받기 힘든 환자들이 집에서도 의료 접근성을 높이기 위해 대한민국의 방문진료가 점차 자리를 잡아가고 있습니다. 그러나 방문진료와 재택의료의 좀 더 대한민국 보건의료의 혁신을 만들어내기 위해서는 몇 가지 개선해야 할 점들이 있습니다.

무엇보다 가장 빨리 개선되어야 할 점은 일반 대중과 잠재적인 환자들이 방문진료 서비스에 대해 잘 모르고 있고, 환자가 해야 하는 본인부담금이 비싸다는 점입니다. 만약 환자의 상태가 나빠지고 심각한 합병증이 생기기 전에, 잠재적인 환자와 가족들에게 방문진료의 이점과 절차에 대해 더 많은 정보를 적극적으로 제공하고, 환자의 본인부담금을 경감해 줌으로써 방문진료의 이용률을 높일 수 있다면, 환자와 가족은 힘든 응급실 이용과 입/퇴원의 고통이 줄어들 뿐 아니라, 바쁘고 대기가 긴 상급 병원의 부담을 감소시키고, 나아가서는 대

한민국 전체 의료비를 아끼는 결과를 만들 수 있을 것입니다.

다음으로는 방문진료 의사의 참여를 늘릴 수 있는 보상 기전과 유인책이 만들어져야 한다는 점입니다. 〈일방시〉에 참여하는 의사는 '방문진료료'라는 항목의 수가를 받을 수 있는데, 이전에 비해 금액이 인상되고 '동반인력가산 수가'가 생기면서 보상이 나아진 것은 사실입니다. 하지만 본사업에 참여하는 대부분의 의원급 의료기관들이 외래 환자를 진료하는 것을 포기하고 방문진료 나가는 것을 선택하기에는 아직 부족한 수준입니다.

그래서 〈일방시〉에 참여하는 많은 방문진료 의사들은 짧은 점심 시간이나 진료 후 야간 시간 등을 이용하여 방문진료를 나가는 실정입니다. 그리고 방문진료 대상 환자들은 밤 늦은 시간이나 휴일에도 상태가 나빠질 가능성이 높아, 방문진료 의사들은 늘 긴장하고 있어야 합니다. 방문진료와 관련된 서류 작업과 사회복지 서비스 연계를 위한 행정 절차를 소화해야 하는

것도 덩입니다.

이렇게 휴식 없이 방문진료를 수행하는 의사들의 번아웃을 어떻게 막을 지도 고민해야 합니다. 게다가 낮은 방문진료 수가와 방문진료 건수의 제한으로 인해 의사를 추가로 구인하는 것도 난감합니다. 지속 가능한 방식으로 방문진료가 고령화 대한민국에 자리잡기 위해서는 방문진료 의사에 대한 처우 개선을 서둘러야 합니다.

그리고 현실적인 수가 보상으로 방문진료에 참여하는 의사의 숫자를 늘리고, 관련된 행정 절차를 간소화해야 합니다. 이미 개설한 의료기관뿐 아니라 개원을 준비하는 의사들에게도 방문진료를 홍보하고, 개업과 진료를 시작하는 시점부터 〈일방시〉에 참여할 수 있게 지침을 개정하여, 지역의 방문진료를 전문적으로 책임질 의원급 의료기관의 개설을 유도하는 것도 필요합니다.

오늘도 몇 건의 방문진료를 마치고 병원으로 돌아왔습니다. 비가 갑자기 많이 와서 교통 체증이 심했고, 시야가 안 좋는데

좁은 골목길로 운전하다가 사고가 날까 봐 걱정되기도 했습니다. 어렵게 주차를 마치고 환자의 집에 들어갔더니 아직 간병에 서투른 보호자가 욕창 환자의 대소변 처리를 하지 못해, 같이 간 간호사와 환자의 몸을 물수건으로 닦아주고 기저귀와 시트를 갈아주었습니다. 돌아오는 차 안에서 아직도 내 몸에는 환자의 대소변 냄새가 나

는 것 같지만, 보호자가 챙겨준 음료수를 마시면서 차창 밖의 어스름한 저녁 하늘을 바라보니 무언가 힐링이 되는 느낌을 지울 수 없습니다.

수가가 부족하고 제도가 미비함에도 집에서 의료 서비스를 받지 못해 힘들어하는 환자들을 차마 두고 볼 수 없어서 방문진료를 나서는 대한민국의 의사들이 많아

지고 있습니다. 이들은 이타성이라는 우리 안의 선한 본성과 모든 인간은 존엄하다는 우리의 믿음으로 나서고 있는 것입니다.

대한민국 보건의료의 혁신은 AI와 같은 최첨단 과학 기술이 아니라 이러한 신념으로 만들어질 수 있을지도 모르겠습니다.